

Số: 514 /BVVPMED-HĐT&ĐT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC MỚI
Thuốc điều trị tăng huyết áp CANDESARTAN PLUS

Để có thêm lựa chọn thuốc cho toàn thể bệnh viện, khoa Dược đã tiến hành cung ứng thuốc điều trị tăng huyết áp CANDESARTAN PLUS. Đồng thời, tổ Thông tin thuốc xin gửi đến các khoa phòng điều trị một số thông tin liên quan sau đây.

1. Thành phần và cơ chế tác dụng của thuốc

- Thành phần dược chất: Candesartan cilexetil 8mg & Hydrochlorothiazid 12,5mg
- Cơ chế tác dụng: Candesartan là thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II (chọn lọc trên thụ thể AT1), có tác dụng ngăn chặn co mạch và giảm tiết aldosteron. Hydrochlorothiazid là thuốc lợi tiểu thiazid, giúp làm giảm tái hấp thu natri, từ đó tăng bài tiết nước tiểu. Sự kết hợp này mang lại tác dụng hạ huyết áp hiệp đồng, giúp hạ huyết áp mạnh hơn so với khi dùng từng thành phần đơn độc
- Dạng bào chế: viên nén màu trắng hoặc trắng ngà, hình trụ, một mặt có vạch bẻ ở giữa và cạnh viên lằn lặn.

2. Chỉ định và liều dùng:

- Chỉ định: Điều trị bệnh tăng huyết áp ở bệnh nhân không được kiểm soát tốt với đơn trị liệu bằng candesartan cilexetil hoặc hydrochlorothiazid
- Liều dùng: Người lớn: 1 viên/lần x 1 lần/ngày. Thuốc có thể uống cùng hoặc không cùng với thức ăn

3. Các chống chỉ định của thuốc:

- Quá mẫn với candesartan, các dẫn chất sulfonamid (do hydrochlorothiazid là một dẫn chất sulfonamid) hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Phụ nữ có thai (đặc biệt ở giai đoạn thứ hai và thứ ba của thai kỳ) Bệnh nhân suy thận nặng (Độ thanh thải Creatinin ClCr < 30 ml/phút).
- Bệnh nhân suy gan nặng và/hoặc ứ mật.
- Hạ kali máu và tăng calci máu kháng trị.
- Bệnh nhân bị bệnh gút.
- Sử dụng đồng thời CANDESARTAN PLUS 8/12,5 với các sản phẩm chống chỉ định với các bệnh nhân tiểu đường suy nhược hoặc suy thận (GFR < 60 ml/phút/1,73m²)

4. Tương tác thuốc:

- Thuốc chống viêm không steroid (NSAID): Có thể làm giảm tác dụng hạ huyết áp của thuốc và tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận cấp.
- Các thuốc ảnh hưởng đến nồng độ kali: Dùng chung với thuốc lợi tiểu thải kali, corticosteroid, thuốc nhuận tràng có thể làm hạ kali máu. Ngược lại, dùng chung với thuốc lợi tiểu giữ kali hoặc chất bổ sung kali có thể làm tăng kali máu.
- Rượu, barbiturat, thuốc ngủ: Có thể làm tăng nguy cơ hạ huyết áp tư thế đứng.
- Thuốc điều trị đái tháo đường (đường uống và insulin): Có thể cần phải điều chỉnh liều thuốc đái tháo đường khi dùng chung
- Các amin làm tăng áp lực máu (như adrenalin): Hydroclorothiazid có thể gây ra đáp ứng động mạch với để làm giảm áp suất nhưng không đủ để loại trừ hoàn toàn tác động của tăng áp lực máu.
- Chất cản quan iod khi dùng liều cao cùng với Hydroclorothiazid có thể tăng nguy cơ suy thận cấp.
- Các thuốc chẹn beta và diazoxid có thể làm tăng đường huyết khi dùng cùng thiazid.
- Các thuốc kháng cholinergic (atropin, biperiden) có thể làm tăng sinh khả dụng của thuốc lợi tiểu thiazid bằng cách giảm nhu động đường tiêu hóa và tốc độ tháo rỗng dạ dày.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm các sản phẩm, Dược thư Quốc gia Việt Nam 3 hoặc trao đổi với bộ phận Dược lâm sàng – Thông tin thuốc.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc bệnh viện (chỉ đạo);
- Các khoa lâm sàng;
- Lưu VT; KD.

**TM. HĐ THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII. NGUYỄN VĂN ĐỐI**